



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 319.31/I-PDM/IGD/IV/2025

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Disusun oleh :

Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat (IGD) ini meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit..

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat (IGD) ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENORGANISASIAN IGD

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	2
2.1 Deskripsi RS Prima Husada	2
2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada	2
BAB 3 VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN	4
3.1 Visi	4
3.2 Misi	4
3.3 Falsafah	4
3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	4
3.5 Tujuan	4
3.6 Motto	4
BAB 4 STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA	5
4.1 Bagan Organisasian	5
4.2 Keterangan/pengertian	6
BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GAWAT DARURAT	8
BAB 6 URAIAN JABATAN	9
6.1 Uraian jabatan	9
6.2 Tugas Klinis	15
BAB 7 TATA HUBUNGAN KERJA	22
7.1 Pola Hubungan Kerja	22
BAB 8 POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI	24
8.1 Pola Ketenagaan	24
8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf	25
8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf	26
8.4 Jumlah Staf Unit	26
8.5 Seleksi Calon Karyawan	26
8.6 Pengembangan SDM	27
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI	28
BAB X PERTEMUAN RAPAT	30
BAB XI PELAPORAN	31
11.1 Pengertian	31
11.2 Jenis Laporan	31

DAFTAR TABEL

6.1 Uraian Jabatan	9
7.1 Tabel Pola Hubungan dengan Instalasi / Unit Pelayanan Struktural	22
7.2 Tabel Pola Hubungan dengan Instalasi/Unit Penunjang	22
8.4 Tabel Kualifikasi Ketenagaan Instalasi Rawat Inap	26



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 319.31/I-PDM/IGD/IV/2025**

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 (tentang Standarisai Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malangxx/-[f v v
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
GAWAT DARURAT (IGD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darutrat.

(2) Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat dalam organisasi dan manajemen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Prima Husada.



BAB II SKRINING

Pasal 2

- (1) Skrining di dalam maupun luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan / spesifik untuk menetapkan pasien diterima atau dirujuk;
- (2) Pelaksanaan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- (3) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- (4) Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging;
- (5) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani;
- (6) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien;
- (7) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien;
- (8) Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB III TRIASE

Pasal 3

- (1) Kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triase dan tindakan penyelamatan nyawa (life saving);
- (2) Pada setiap pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus dilakukan triase berbasis bukti;
- (3) Triase merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratannya dan prioritas penanganan;
- (4) Setiap staf harus terlatih dalam menggunakan kriteria;
- (5) Prioritas diberikan kepada pasien dengan kebutuhan mendesak.



BAB IV PENUNDAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap harus disampaikan kepada pasien;
- (2) Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien dan dicatat di rekam medis.

BAB V ALUR PASIEN

Pasal 5

- (1) Alur pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Alur pendaftaran pasien rawat inap;
- (3) Alur pendaftaran pasien gawat darurat;
- (4) Alur penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap;
- (5) Alur menahan pasien untuk observasi;
- (6) ALur mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit;
- (7) Proses pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online;
- (8) Pasien gawat darurat tidak ditarik uang muka untuk pelayanan;
- (9) Alur untuk menghindari penumpukan termasuk pada keadaan bencana;
- (10) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien;
- (11) Komponen dari pengelolaan alur pasien meliputi :
 - (a) ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - (b) perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
 - (c) perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
 - (d) alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anestesi);
 - (e) efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);
 - (f) pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - (g) akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).



BAB VI
HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

Pasal 6

- (1) Rumah sakit menetapkan tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga;
- (2) Pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga atau pihak lain;
- (3) Semua staf memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga;
- (4) Staf bertanggung jawab melindungi hak pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, serta menghormati dan menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan;
- (2) Rumah sakit menanggapi permintaan rutin termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama dengan memfasilitasi bimbingan kerokhanian di rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengatur tentang kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien;
- (2) Pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pasien harus diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi medis;
- (4) Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien;
- (5) Staf mampu mengidentifikasi dan menghormati harapan dan kebutuhan privasi saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan, dan transfer pasien.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien dengan menyediakan tempat penyimpanan khususdikarenakondisi pasien tertentu yang tidak mampu menjaga barang miliknya saat di rumah sakit;
- (2) Staf mampu menjelaskan tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik pasien tersebut kepada pasien.

Pasal 10

Rumah sakit melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan diantaranya ruang bayi, kamar operasi dan kasir (pembayaran).



Pasal 11

- (1) Pasien dan keluarga ikut berpartisipasi dalam proses asuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya;
- (2) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Pasal 12

- (1) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga;
- (2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti;
- (3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4) Pasien dijelaskan bila ada tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan proses memberikan persetujuan;
- (5) Pasien dijelaskan hasil yang diharapkan maupun kemungkinan hasil tidak terduga dari proses asuhan dan pengobatan;
- (6) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan.

Pasal 13

- (1) Rumah sakit mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA;
- (2) Pasien dijelaskan diagnosis, kondisi pasien, tindakan yang diusulkan, tata cara dan tujuan tindakan, manfaat dan risiko tindakan, DPJP pelaksana tindakan, kemungkinan alternatif dari tindakan, prognosis, kemungkinan hasil yang tidak terduga serta kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan
- (3) DPJP, PPJA, dan PPA harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien.

Pasal 14

- (1) Pasien serta keluarganya berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan;
- (2) Pasien dan keluarga dijelaskan konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan tersebut;
- (3) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Pasal 15

Rumah sakit menetapkan peraturan pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat.



BAB VII TRANSFER INTRAHOSPITAL

Pasal 16

- (1) Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien;
- (2) Form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat;
- (3) Form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostic;
- (4) Form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat;
- (5) Form tersebut memuat setiap prosedur yang dilakukan;
- (6) Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan;
- (7) Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer);
- (8) Ketentuan tersebut dilaksanakan.

BAB VIII RUJUKAN

Pasal 17

- (1) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - (a) diagnosis dan teramelaipi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - (b) alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - (c) risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - (d) transportasi rujukan;
 - (e) risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 18

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah :

- (1) melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (2) melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
- (3) membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.



Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat :

- (1) identitas pasien;
- (2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- (3) diagnosis kerja;
- (4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- (5) tujuan rujukan;
- (6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien;
- (2) Selama proses transportasi rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- (3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

Pasal 21

Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 319.31/I-PDM/IGD/IV/2025
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik. Dalam hal penunjang medik, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang farmasi yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat yang siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit, baik petugas maupun pasien. Instalasi farmasi di rumah sakit harus memiliki organisasi yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1 Deskripsi RS Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email primahusadamalang@gmail.com/info@rs-primahusada.id, website www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi Rs Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	:	Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	:	Menjadi tempat dokter internsip

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5 Tujuan

Rumah Sakit Prima Husada memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada.

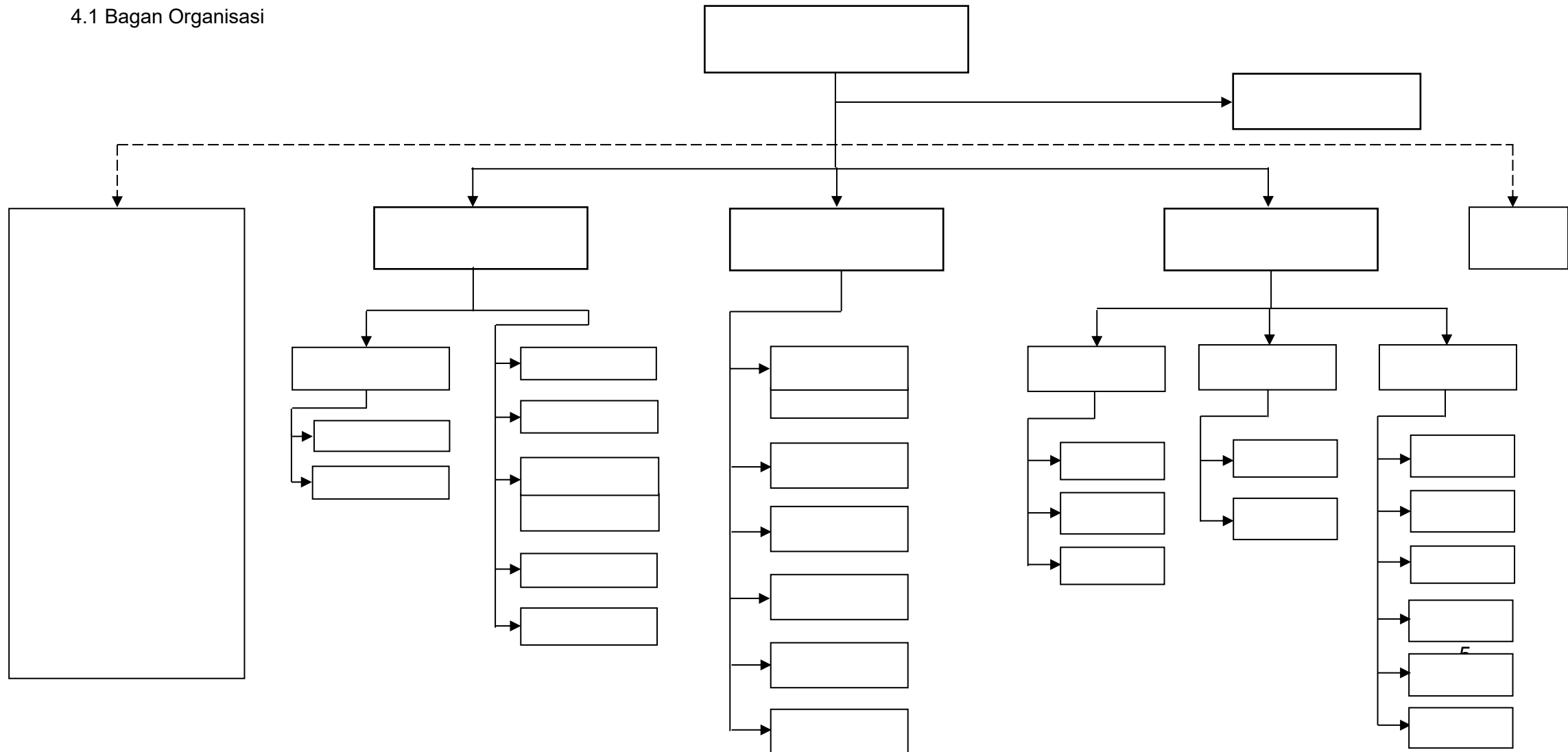
3.6 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB 4

STRUKTUR ORGANISASI RS. PRIMA HUSADA

4.1 Bagan Organisasi



4.2 Keterangan/Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.

2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.

3) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :

a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .

b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.

c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

c. Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

1) Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

d. Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit

2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.

3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KOntrak dan Pengaduan Pelayanan

e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
 - a) Kepala Instalasi Rawat Inap
 - b) Kepala *Intensive Care Unit*
 - c) Kepala Instalasi Gawat Darurat
 - d) Kepala Instalasi Kamar Operasi
 - e) Kepala Instalasi Farmasi
 - f) Kepala Instalasi Rekam Medis
 - g) Kepala Unit Laboratorium
 - h) Kepala Unit Radiologi
 - i) Kepala Unit Gizi
 - j) Kepala Unit Laundry
 - k) Kepala Unit Kamar Jenazah
 - l) Kepala Unit Fisioterapi
 - m) Kepala Bagian SDM
 - n) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - o) Kepala Bagian Umum

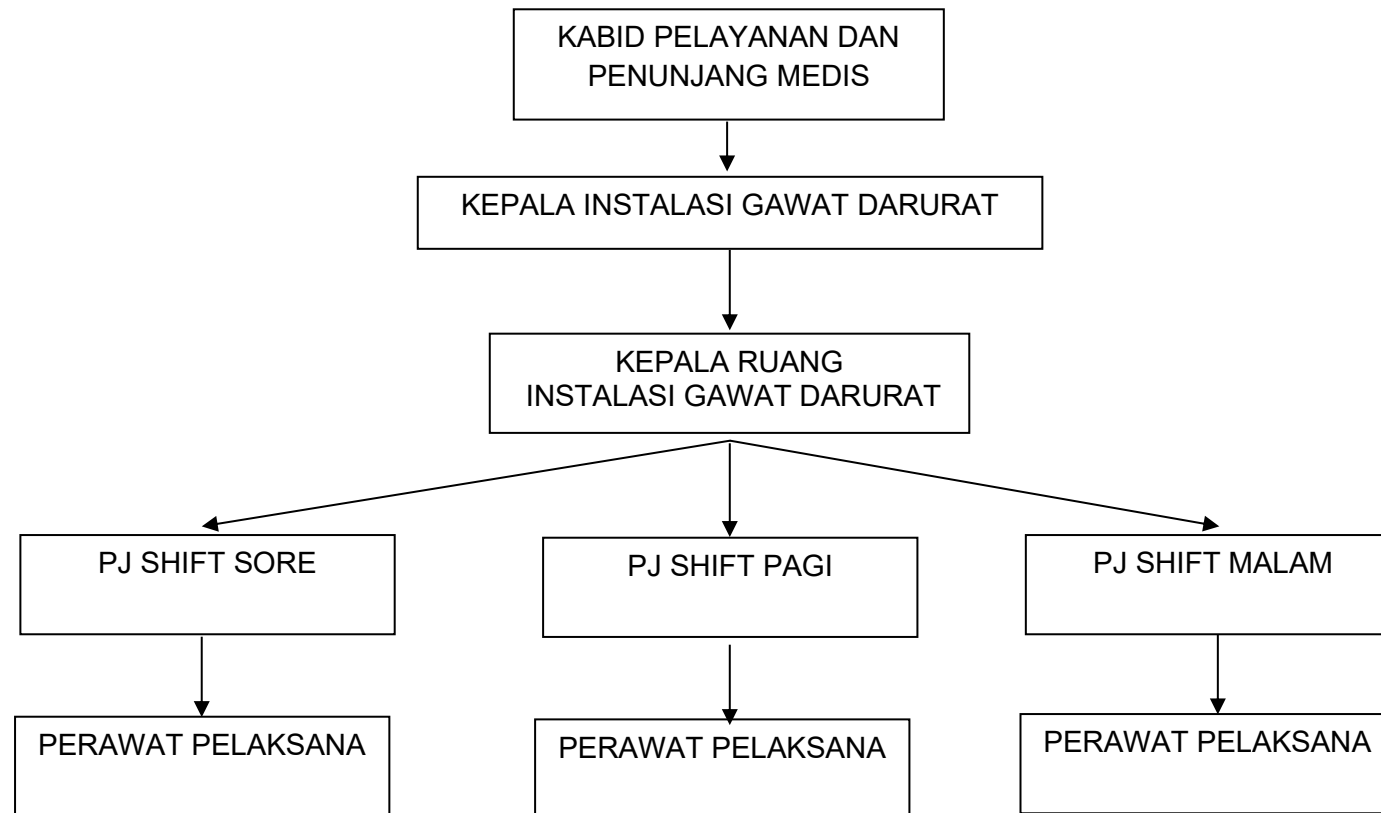
2) Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/Panitia/Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

- a) Komite Medik
- b) Komite Keperawatan
- c) Komite PPI
- d) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e) Komite Etik
- f) Komite Farmasi & Terapi
- g) Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i) Tim Review Rekam Medis
- j) Tim TB DOTS
- k) Tim PONEK
- l) Tim Geriatri
- m) Tim HIV
- n) Tim PKRS
- o) Tim Casemix

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GAWAT DARURAT



BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1 Uraian Jabatan

No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
1	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1. Pendidikan : a. Lulusan S1 Pendidikan Dokter/ Dokter Spesialis b. Memiliki STR dan SIP Dokter yang masih berlaku, Surat sumpah dokter 2. Pengetahuan dan Keterampilan : a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi b. Mempunyai kemampuan menangani pasien umum, gawat darurat & Penggunaan alat medis yg berhubungan dgn penanganan pasien IGD 3. Pengalaman : a. Pengalaman di bidang klinis minimal 3 tahun
		4. Uraian tugas a. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan IGD 1) Pelaksanaan kegiatan. 2) Kebutuhan sumber daya manusia. 3) Anggaran pendapatan dan belanja tahunan. 4) Pengorganisasian pelaksanaan tugas. 5) Petunjuk teknis pelayanan IGD. 6) Petunjuk teknis petugas IGD. 7) Menerima, mendata dan melaporkan kepada atasan tentang adanya masalah ataupun kasus - kasus di IGD sekaligus melakukan perbaikan b. Memberikan pengarahan dan motivasi kepada tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya. c. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di ruangan IGD d. Mengadakan pertemuan berkala, membahas permasalahan atau perkembangan baru di unit IGD. e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan f. Mengenal dan mengetahui penggunaan barang/alat serta mengusahakan pengadaannya. g. Menyusun permintaan rutin kebutuhan ruangan h. Mempertanggung jawabkan pemeliharaan alat/inventaris peralatan. i. Memelihara dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua kegiatan di ruangan. j. Memberikan penjelasan pada pasien IGD dan keluarganya sebatas kewenangannya. k. Bekerja sama dengan seluruh sub unit dan profesi di RS Prima HUsada l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. m. Memotivasi tenaga medis, perawatan dan non perawatan

		dalam menjaga kebersihan n. Menilai pelaksanaan SPO medis dan asuhan keperawatan o. Menilai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang medis dan keperawatan p. Mengendalikan pendayagunaan peralatan, keperawatan, obat-obatan secara efektif dan efisien. q. Mengatur jadwal jaga dokter dan perawat IGD r. Sebagai Dokter Full Timer s. Mengikuti rapat dan kegiatan yang diselenggarakan rumah sakit
		5. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab Kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada. b. Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. c. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
		6. Wewenang : a. Melaksanakan pelayanan medik di IGD b. Menyelenggarakan kegiatan unit bermutu c. Melakukan konsul pasien ke konsulen yang bersangkutan atau merujuk pasien sesuai kebutuhan d. Mengusulkan memindahkan pasien dari IGD ke unit lain
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
2	Kepala Ruang IGD	1. Pendidikan : a. Lulusan S1 Keperawatan b. Memiliki STR dan SIKP Perawat yang masih berlaku, Surat sumpah jabatan c. PPGD/BTLS/BCLS/BLS 2. Pengetahuan dan Keterampilan : a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : a. Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
		4. Uraian tugas : 1) Mengatur dan mengkoordinasi seluruh pelayan IGD seperti pelaksanaan kegiatan, kebutuhan sumber daya manusia, anggaran pendapatan dan belanja tahunan, pengorganisaian pelaksanaan tugas, petunjuk teknis pelayanan IGD, petunjuk teknis tugas IGD, menerima, mendata dan melaporkan kepada atasan tentang adanya masalah ataupun kasus – kasus di IGD sekaligus melakukan perbaikan. 2) Memperbaiki pengarahannya dan motivasi kepada tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya. 3) Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di ruangan IGD 4) Mengadakan pertemuan berkala, membahas permasalahan atau perkembangan baru di unit IGD 5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

		6) Mengenal dan mengetahui penggunaan barang / alat serta mengusahakan pengadaannya. 7) Menyusun permintaan rutin kebutuhan ruangan. 8) Mempertanggung jawabkan pemeliharaan alat/inventaris peralatan. 9) Memelihara dan mengembangkan system peralatan dan pelaporan semua kegiatan di ruangan. 10) Memberikan penjelasan pada pasien IGD dan keluarganya sebatas kewenangannya. 11) Bekerja sama dengan seluruh sub unit dan profesi di RS Prima husada. 12) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik 13) Memotivasi tenaga medis, perawat dan non perawat dalam menjaga kebersihan 14) Menilai pelaksanaan SPO medis dan asuhan keperawatan 15) Menyusun rencana kegiatan berdasarkan jenis, jumlah, mutu tenaga keperawatan serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan di IGD. 16) Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Gawat Darurat dan melaksanakannya. 17) Menyusun dan mengatur daftar dinas tenaga perawat yang berlaku tiap minggu. 18) Melakukan tindakan darurat sesuai dengan kebutuhan pasien seperti mengamati keadaan pasien (tanda vital, kesadaran, mental, keluhan), melakukan anamnesa, menyiapkan bahan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. 19) Membantu pasien selama pemeriksaan dokter dengan cara : memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan. 20) Memastikan bahwa semua hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium telah tervalidasi dengan baik dan benar 21) Memastikan bahwa semua hasil nilai kritis laboratorium telah dilaporkan dengan baik dan benar. 22) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang laboratorium, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan pelatihan. 23) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. 24) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dan rancang ulang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unitnya. 25) Melakukan evaluasi terhadap perijinan bagi diri sendiri, staf di bawahnya, fasilitas yang ada dan hal-hal terkait, sesuai peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. 26) Melakukan evaluasi terhadap mutu dari proses kerja sama dengan unit dan instansi lain. 27) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. 28) Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana 29) Mewakili kepala instalasi IGD bila tidak ada ditempat
--	--	---

		30) Good attitude (tidak hanya sikap baik tetapi juga sifat yang baik dan pikiran positif). 31) Mengerti tentang obat-obatan yang tersedia di rumah sakit dan ketentuan atau program-program rumah sakit. 32) Melakukan triase saat pasien pertama kali masuk Instalasi Gawat Darurat. 33) Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang sederhana menegakan diagnosis kerja setiap pasien baru masuk dan kemudian memberikan tindakan dan terapi emergensi sesuai dengan diagnosis sementara yang ditegakkan sesuai dengan disiplin ilmu dan kewenangan klinis kemudian di dokumentasikan pada asesmen IGD. 34) Melakukan monitoring pasien gawat darurat sampai keadaan pasien stabil untuk dilakukan transfer. 35) Datang tepat waktu sesuai dengan shift jaga. 36) Mengkonsulkan pasien yang akan di rawat inapkan kepada DPJP sebelum masuk ruangan. 37) Membantu pertolongan bagi pasien rawat inap yang membutuhkan pertolongan gawat darurat dalam kondisi dokter ruangan tersebut halangan atau menangani pasien emergency lain. 38) Berperan aktif dalam penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 39) Melaksanakan tugas luar rumah sakit jika diperlukan sewaktu-waktu. 40) Mengikuti rapat yang diselenggarakan rumah sakit. 41) Melaksanakan pelayanan medis di IGD selama 24 jam secara bergiliran.
		5. Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi gawat darurat b. Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi gawat darurat
		6. Wewenang : a. Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi gawat darurat b. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan c. Pengembangan tata laksana kerja, tugas-tugas, dan tanggungjawab d. Melakukan pembagian tugas di lingkup internal instalasi gawat darurat e. Membantu melaksanakan program orientasi untuk karyawan di IGD f. Melakukan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dalam lingkup kinerjanya. g. Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan h. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan/tata tertib yang berlaku di rumah sakit serta fasilitas yang ada dan cara penggunaanya i. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik

		dengan instalasi/bagian lain yang terkait j. Berperan serta dalam membahas kasus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu k. Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga perawat dari segi jumlah maupun kualifikasi di instalasi gawat darurat. l. Memantau penerapan SOP dan mengevaluasi m. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
3	Perawat Pelaksana	1. Pendidikan : a. Lulusan S1/ D3 Keperawatan b. Memiliki STR dan SIKP Perawat yang masih berlaku, Surat sumpah jabatan c. PPGD/BTLS/BCLS/BLS 2. Pengetahuan dan Keterampilan : a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : a. Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
		4. Uraian tugas : a. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan UGD untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan b. Melayani pasien baru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku c. Melakukan tindakan medis /intervensi kepada pasien sesuai dengan kapasitasnya d. Membantu dokter dalam memberika pelayanan / pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat dan darurat e. Memelihara peralatan kesehatan / medis agar selalu dalam keadaan siap pakai f. Menciptakan hubungan kerjasama yag baik dengan pasien dan keluarganya maupun sesama petugas g. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien sesuai dengan batas kemampuannya,dengan cara : 1) Mengamati keadaan pasien (tanda vitak, kesadaran, keadaan mental , keluha utama) 2) Melaksanakan anamesa 3) Menyiapkan formulir untuk penyelesaian adminitrasi, seperti : a) Surat keterangan istirahat sakit, jika diperlukan b) Resep obat untuk dirumah, jika diperlukan c) Surat rujukan atau pemeriksaan ulang d) Perincian biaya pengobatan pasien h. Memberikan Penyuluhkan kesehatan kepada pasien dan keluarganya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien, menenai : 1) Diit 2) Pengobatan yang perlu dilanjutkan dan cara penggunaanya

		3) Pentingnya pemeriksaan ulang / kontrol dirumah sakit, puekesmas atau instalasi pelayanan kesehatan lainnya 4) Cara hidup sehat, seperti pengaturan istirahat, makanan yang berizi i. Melatih pasien menggunakan alat bantu yang digunakan. j. Melatih pasien untuk melaksanakan tindakan Keperawatan dirumah misalnya : 1) Merawat luka 2) Melatih anggota gerak dan mengatur diit. 3) Kepatuhan minum obat serta pantangan yang tidak boleh dilakukan k. Mengatur pasien yang akan dirawat sampai ke ruangan yang dituju l. Mengatur pasien yang akan pulang sampai dipintu keluar ruang UGD bila keadaan memungkinkan. m. Melakukan pengecekan alat setiap pergantian shift serta membersihkan,merapikan,dan menyiapkan alat setelah dipakai untuk tindakan berikutnya. n. Melakukan pengecekan obat serta melengkapi stock obat setelah obat dipakai degan cara mengambil pergantian obat dari pasien o. Menyiapkan BHP untuk keperluan IGD p. Bekerjasama untuk menjaga , memelihara ,membersihkan ,merapikan alat –alat yang ada di IGD. q. Membuat laporan harian pasien r. Membuat asuhan keperawatan (melengkapi status IGD) s. Disiplin : 1. Datang tepat waktu 2. Mengisi absensi 3. Berpakaian rapi dan bersih 4. Ramah,sopan,santun (beretika) 5. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit raflesia. t. Melakukan perhitungan dan pencatatan perincian biaya pasien IGD yang dilakukan oleh shift malam dan shift pagi melaporkanya keuangan setiap harinya u. Bekerja secara professional
		5. Tanggung Jawab a. Langsung : Kepala Ruang UGD b. Tidak langsung : Kabid Keperawatan
		6. Wewenang a. Meminta informasi dan petunjuk pada atasan b. Memberi asuhan Keperawatan pada pasien/ keluarga pasien sesuai dengan kemampuan dan batas wewenangnya

6.2 Tugas Klinis

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

1. Dokter
- a. Kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

b. Kewajiban merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

c. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

d. Kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e. Kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

f. Kewajiban untuk menunjuk staf medis lain dalam keahlian yang sama sebagai pengganti apabila berhalangan, jika tidak harus diinformasikan kepada pasien yang bersangkutan.

g. Kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum persetujuan tindakan disetujui pasien (informed consent).

h. Kewajiban membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya.

i. Kewajiban menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.

j. Kewajiban untuk mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat dan formularium rumah sakit.

2. Perawat

a. Perawat Klinik I

Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan dibawah bimbingan. Kompetensi perawat klinis I yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan asuhan keperawatan (pengkajian,menetapkan diagnosis keperawatan,menetapkan intervensi dan melaksanakan tindakan keperawatan serta evaluasi) dengan lingkup keterampilan tehnik dasar.
2.	Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan keperawatan.
3.	Melakukan komunikasi terapeutik di dalam asuhan keperawatan.
4.	Menerapkan caring dalam keperawatan.
5.	Menerapkan prinsip keselamatan klien.
6.	Menerapkan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi.
7.	Melakukan kerjasama tim dalam asuhan keperawatan.
8.	Menerapkan prinsip mutu dalam tindakan keperawatan.
9.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien terkait dengan kebutuhan dasar.
10.	Mengumpulkan data kuantitatif untuk kegiatan pembuatan laporan kasus klien.
11.	Mengumpulkan data riset sebagai anggota tim penelitian.

12.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku,agama, ras dan antar golongan.
13.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
14.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
15.	Menunjukkan sikap asertif.
16.	Menunjukkan sikap empati.
17.	Menunjukkan sikap etik.
18.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
19.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
20.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
21.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

b. Perawat Klinik II

Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola klien/sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut/kompleks. Kompetensi perawat klinis II yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan proses keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan partial dan total care.
2.	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
3.	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien.
4.	Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien untuk menentukan intervensi keperawatan.
5.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien.
6.	Menerapkan prinsip etik, legal, dan pekabudaya dalam pemberian asuhan keperawatan.
7.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
8.	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
9.	Melakukan kajian insiden keselamatan klien dan manajemen risiko klinis.
10.	Melakukan kajian terhadap kejadian dan risikoinfeksi pada klien.
11.	Melakukan kerjasama antar tim.
12.	Menerapkan pengendalian mutu dengan satu metoda tertentu sesuai kebijakan rumah sakit setempat.
13.	Mengimplementasikan pengendalian mutu asuhan keperawatan.
14.	Merumuskan kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien.
15.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga.
16.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga.
17.	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan dan rencana tindak lanjut.

18.	Melaksanakan preceptorsip pada tenaga perawat di bawah bimbingannya dan praktikan.
19.	Melakukan diskusi refleksi kasus untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan.
20.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan.
21.	Membantu pelaksanaan riset keperawatan deskriptif.
22.	Melakukan survey keperawatan.
23.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku,agama, ras dan antar golongan.
24.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
25.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
26.	Menunjukkan sikap asertif.
27.	Menunjukkan sikap empati.
28.	Menunjukkan sikap etik.
29.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
30.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
31.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
32.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

c. Perawat Klinik III

Perawat Klinis III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis III yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan partial dan total dengan masalah kompleks diarea keperawatan spesifik.
2.	Menerapkan filosofi dasar keperawatan padaarea keperawatan spesifik.
3.	Menerapkan penyelesaian dan pengambilan keputusan masalah etik,legal dalam asuhan keperawatan di unit keperawatan.
4.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien pada lingkup area spesifik.
5.	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
6.	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada unit ruang rawat.
7.	Menggunakan metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit ruang rawat
8.	Menetapkan masalah mutu asuhan keperawatan berdasarkan kajian standar dan kebijakan mutu.
9.	Melaksanakan analisis akar masalah (RCA) dan membuat grading risiko terhadap masalah klinis.
10.	Mengidentifikasi kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien di area spesifik.
11.	Mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang tersedia untuk edukasi kesehatan pada area spesifik.

12.	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan.
13.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dan keluarga pada area spesifik.
14.	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien di area spesifik.
15.	Menerapkan prinsip kerja sama interdisiplin.
16.	Melaksanakan pengendalian mutu asuhan keperawatan di unit.
17.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesifik.
18.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesifik.
19	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesifik dan rencana tindak lanjut.
20.	Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesifik.
21.	Menginterpretasi hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
22.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
23.	Melakukan riset keperawatan deskriptif analitik dan inferensial.
24.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
25.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
26.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
27.	Menunjukkan sikap asertif.
28.	Menunjukkan sikap etik.
29.	Menunjukkan sikap empati.
30.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
31.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
32.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
33.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

d. Perawat Klinik IV

Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhankeperawatan pada masalah klien yang kompleksdiarea spesialistik dengan pendekatan tata kelolaklinis secara interdisiplin, multidisiplin, melakukankriset untuk mengembangkanpraktek keperawatanserta mengembangkan pembelajaran klinis.Kompetensi perawat klinis IV yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan total dengan masalah kompleks di area spesialistik.
2.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan pada lingkup masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
3.	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan keperawatan.
4.	Melakukan evaluasi efektifitas metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit.

5.	Merumuskan indikator keberhasilan intervensi keperawatan.
6.	Menetapkan pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialistik.
7.	Menetapkan upaya perbaikan mutu.
8.	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik,legal dalam asuhan keperawatan dalam berbagai lingkup pelayanan keperawatan.
9.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik klien dengan masalah kompleks di area spesialistik.
10.	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dengan kasus spesialistik.
11.	Melaksanakan risiko klinis menggunakan pendekatan Healthcare Failure Mode & Effect Analysis atau Analisis Efek & Mode Kegagalan di Pelayanan Kesehatan (HFMEA).
12.	Menerapkan prinsip kerjasama secara interdisiplin /interprofesional.
13.	Melakukan upaya perbaikan mutu asuhan keperawatan dengan memberdayakan sumber terkait.
14.	Melakukan pengendalian mutu asuhan keperawatan di beberapa unit.
15.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesialistik.
16.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesialistik.
17.	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesialistik dan rencana tindak lanjut.
18.	Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesialistik.
19.	Menganalisis hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialistik.
20.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialistik.
21.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku,agama, ras dan antar golongan.
22.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
23.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
24.	Menunjukkan sikap asertif.
25.	Menunjukkan sikap empati.
26.	Menunjukkan sikap etik.
27.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
28.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
29.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
30.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

e. Perawat Klinik V

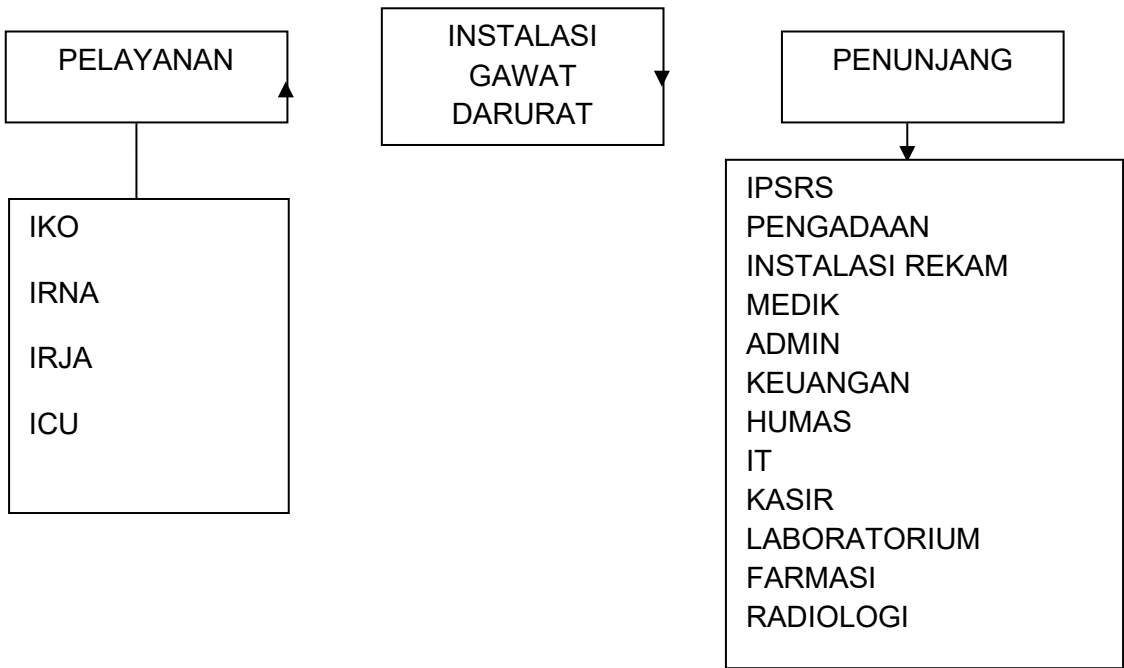
Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialistik, melakukan tatakelola klinis secara transdisiplin, melakukan riset klinis untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan. Kompetensi perawat klinis V yaitu:

No	Kompetensi
1.	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien yang kompleks di area spesialistik.

2.	Merumuskan strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
3.	Menganalisis potensi risiko klinis dari intervensi keperawatan.
4.	Menerapkan prinsip dan model kerjasama secara interdisiplin / interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.
5.	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan.
6.	Mengembangkan metode penugasan berdasarkan bukti ilmiah.
7.	Merumuskan indikator kinerja kunci pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialisik sebagai acuan penilaian.
8.	Mengembangkan metoda perbaikan mutu asuhan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
9.	Menggunakan filosofi dasar keperawatan sebagai dasar keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan spesialisik.
10.	Menyediakan pertimbangan klinis sebagai konsultan dalam asuhan keperawatan klien dengan masalah klien yang kompleks di area spesialisik.
11.	Melakukan pembinaan tata laku dan pertimbangan etik profesi, legal dalam lingkup pelayanan keperawatan.
12.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik, masalah klien yang kompleks di area spesialisik sebagai konsultan.
13.	Menyusun strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
14.	Menggunakan model kerjasama secara interdisiplin /interprofesional pelayanan kesehatan, transdisiplin.
15.	Melakukan pemberian konsultasi klinis dalam asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kompleks pada area spesialisik.
16.	Mengembangkan berbagai alternatif intervensi keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
17.	Mengembangkan sistem dalam menjaga mutu asuhan keperawatan secara keberlanjutan.
18.	Melaksanakan konsultasi dan edukasi kesehatan baik bagi peserta didik, sejawat, klien, maupun mitra profesi sesuai kebutuhan.
19.	Menyediakan advokasi sebagai konsultan dalam pelaksanaan preceptorship dan mentorship.
20.	Mengevaluasi hasil penelitian untuk merumuskan intervensi keperawatan.
21.	Melakukan riset keperawatan semi eksperimental dan eksperimental.
22.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
23.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
24.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
25.	Menunjukkan sikap asertif.
26.	Menunjukkan sikap empati.
27.	Menunjukkan sikap etik.
28.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
29.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
30.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
31.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA



7.1 Pola Hubungan Pelayanan

Tabel 7.1 Pola Hubungan dengan Instalasi / Unit Pelayanan Struktural

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Transfer pasien antar bagian
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	Transfer pasien antar bagian
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	Transfer pasien antar bagian
4.	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	Transfer pasien antar bagian

Tabel 7.2 Pola Hubungan dengan Instalasi / Unit Penunjang

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSRs)	1. Perbaikan peralatan dan sarana instalasi Unit Gawat Darurat 2. Pengkondisian lingkungan area instalasi Unit Gawat Darurat.
2.	Unit Pengadaan	Pengadaan sediaan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3.	Instalasi Rekam Medik	1. Laporan bulanan dan tahunan di instalasi Gawat Darurat 2. Kelengkapan pengisian rekam medis.
4.	Bagian Administrasi	1. Keperluan data dan dokumen.
5.	Unit Keuangan	1. Laporan Stock Opname. 2. Laporan penjualan umum. 3. Laporan penjualan pasien jaminan.
6.	Unit Humas	1. Survei kepuasan Pasien. 2. Standar Pelayanan Minimal.

7.	Tim IT	1. Pengecekan komputer dan perangkatnya. 2. Perbaiki program <i>Billing</i> SIMRS.
8.	UMUM	1. Kebersihan ruangan. 2. Persiapan ruangan untuk <i>event</i> .
9.	KASIR	• Pembayaran pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

8.1 Pola Ketenagaan

Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf dalam upaya mempersiapkan tenaga perawat yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Standar tenaga keperawatan di IGD menggunakan Depkes RI 2005, perhitungan pola ketenagaannya ebagai acuan dari standar perhitungan kebutuhan tenaga yang ada di Instalasi Gawat Darurat (rumus Gillies’ 1996) maka dibawah ini kami lampirkan tingkat ketergantungan pasien sebagai berikut :

No	Katergori Pasien	Rata2 jumlah pasien/ hr	Jumlah jam perawatan px/ hr	Jumlah jam perawatan/ hr (C x D)
A	B	C	D	E
1	Minimal Care	18	2	36
2	Partial Care	11	3,08	33,88
3	Total Care	1	4,15	4,15
4	Intensive Care	0	0	0
	Jumlah	30		74,03

- a.

Jumlah jam perawatan di ruangan / hari

= 74,03 jam
- b.

Jam efektif perawat = 7
- c.

Jumlah hari minggu (1 tahun)

= 52
- d.

Perkiraan cuti

= 12 hari
- e.

Hari besar (1 tahun)

= 14 hari
- f.

Jumlah hari kerja efektif

= 286 hari
- g.

Koreksi 25 %

Sehingga jumlah perawat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : $\frac{74,03}{7} = 10,5$

Langkah 2 : $\frac{52 + 12 + 14}{286} = \frac{78 \text{ hari} \times 10,5}{286} = 2,8$

Langkah 3 : $\frac{10,5 + 2,8}{100} \times 25 = 3,3$

Langkah 4 : Jadi jumlah tenaga perawat yang di butuhkan di Instalasi Gawat Darurat adalah :
 $10,5 + 2,8 + 3,3 = 16,6 \square 17 \text{ orang} + 1 \text{ karu} = 18 \text{ orang}$

Untuk jumlah dokter umum pada RS tipe C sesuai PMK 56 tahun 2014 adalah sebanyak 9 orang.

8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf
 - a. Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar ditempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - b. Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
 2. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama; Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
 3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
2. seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya; bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada

uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

- 1. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- 2. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- 3. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri

Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.4 Jumlah Staf Unit

Tabel 8.1 Kualifikasi Ketenagaan Instalasi Rawat Inap

NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI	JUMLAH SAAT INI	JUMLAH KEBUTUHAN
Ka Instalasi	Dokter/Spesialis	ACLS/BCLS Code Blue HIPERKES PMKP	1	0
Ka Ruangan	S1 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	1	0
Perawat pelaksana	D3 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	10	7

8.5 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Gawat Darurat memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

- 1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husadasendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)

Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar perawat IGD RS Prima Husada :

1. Perawat
 - a. Lulusan S1 Ners/ DIII keperawatan.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Memiliki sertifikasi PPGD dan BTCLS
 - e. Mempunyai pengalaman bekerja di IGD min 1 tahun
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan RS dengan baik.
 - h. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.

8.6 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan keperawatan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat Diploma III diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD
- b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi IGD.

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

Kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat RS Prima Husada, antara lain adalah sebagai berikut :

9.1 Orientasi tenaga medis :

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	1. Penjelasan status kepegawaian 2. Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi 3. Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada 4. Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan 5. Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : a. Visi, misi, nilai, struktur organisasi b. Perjanjian kerja c. Etika bekerja d. Kesejahteraan spiritual e. Service excellence f. Handling complaints g. Produk produk rumah sakit h. <i>Basic life support</i> i. Penanggulangan bencana kebakaran j. Patient safety k. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2.	Mempelajari SPO Keperawatan. Mempelajari Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi Instalasi IGD	2 jam	Ceramah, membaca, dan diskusi	Kepala ruang IGD

3	Pengenalan teknik triase, anamnesa dan pemeriksaan.	2 jam	Ceramah, membaca, dan diskusi	Kepala ruang IGD
4.	Mempelajari dan praktek alur transfer pasien IGD ke IRNA. Mempelajari tata cara penentuan dan penerimaan kriteria masuk dan keluar IGD	5 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Kepala ruang IGD
5.	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien yang membutuhkan instalasi Rawat Inap maupun Rawat Jalan. Pengisian RM pasien. Konsul dan Visite dokter. Mempelajari <i>items</i> pada SIM-RS instalasi Gawat Darurat.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Kepala ruang IGD

BAB X

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional di Instalasi IGD Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi IGD.
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi IGD

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

Rapat Rutin

1. Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan pada setiap rabu jam 13.30 s/d selesai di Hall Akasia. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruangan, dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
2. *Daily* report dilakukan setiap hari jam 13.00-14.00 yang bertempat di Hall Akasia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit untuk membahas permasalahan di masing-masing unit serta update informasi terbaru mengenai RS Prima Husada.
3. Rapat internal Instalasi IGD dilakukan pada minggu pertama 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim Instalasi IGD RSPH untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, *update* keilmuan, dan lain-lain.

Rapat Insidentil

1. Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

BAB XI

PELAPORAN

11.1 Pengertian

Pelaporan merupakan sistim atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan pemberian pelayanan gawat darurat di IGD.

11.2 Jenis Laporan

Laporan dibuat oleh kepala Ruang IGD. Adapun jenis laporan yang dikerjakan terdiri dari :

1. Laporan Harian

Laporan yang dibuat oleh Penanggung Jawab Shift dalam bentuk tertulis setiap hari. Adapun hal – hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan kunjungan pasien IGD
- b. Laporan SDM IGD
- c. Laporan keadaan sarana dan fasilitas IGD
- d. Laporan mutu pelayanan

2. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh kepala ruang IGD dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada Admin Per setiap tanggal 26. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan kunjungan pasien IGD yang meliputi :
 - 1) Jumlah kunjungan pasien IGD berdasarkan kasus (Triage warna).
 - 2) Jumlah kunjungan pasien IGD berdasarkan kasus (Pulang, Rawat, Konsul, Rujuk, Observasi, menolak rawat).
 - 3) Jumlah Kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaan yang datang ke IGD (JKK, Jasaraharja) (Pulang, Rawat, Konsul, Rujuk, Observasi, Menolak rawat).
 - 4) Jumlah Pasien Meninggal.
 - 5) Jumlah kasus penyakit terbanyak di IGD
 - 6) Jumlah pemeriksaan penunjang pasien IGD
- b. Laporan SDM IGD yang meliputi :
 1. Kuantitas SDM (Dokter dan Perawat IGD)
 - 2) Kualitas SDM (Dokter dan Perawat IGD)
- c. Laporan keadaan fasilitas dan sarana IGD yang meliputi :
 - 1) Kelengkapan Alat dan Fasilitas.
 - 2) Kondisi alat dan Fasilitas
- d. Laporan Mutu Pelayanan IGD meliputi :

No	Indikator Mutu	Standar
1.	Angka pasien meninggal di IGD	0%
2.	Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat> 5 menit	0%
3.	Angka ketidaklengkapan assesmen awal medis DPJP pasien rawat inap> 24 jam	0%
4.	Angka ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan/ penolakan tindakan	0%
5.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam	0
6.	Angka ketidakpahaman staf terhadap evakuasi bencana	0 %
7.	Kejadian tidak terpasangnya gelang identitas pasien rawat inap	0

8.	Angka ketidaklengkapan konfirmasi dalam proses baca ulang (<i>the read-back process</i>)	0%
9.	Kejadian tidak dipasangnya label pada obat <i>High alert</i>	0
10.	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi dengan organ 2 sisi (<i>site marking</i>)	0
11.	Angka ketidakpatuhan petugas dalam melakukan cuci tangan 5 moment	0 %
12.	Angka ketidakpahaman pasien terhadap resiko jatuh	0%
13.	Angka ketidaklengkapan formulir kelengkapan rujukan	0%
14.	Angka ketidaklengkapan asesmen IGD > 24 jam sesuai kerangka waktu	0%

e. Laporan pemasukan dan pengeluaran IGD meliputi : laporan pengeluaran pemasukan ATK, ART dan Floor stock IGD.

3. Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Ka unit dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada Kabid Pelayanan dan Penunjang. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- Laporan kunjungan pasien IGD dan Evaluasi dalam 1 tahun.
- SDM / Ketenagaan di IGD dan evaluasi dalam 1 tahun.
- Laporan keadaan fasilitas dan sarana di IGD dan evaluasi dalam 1 tahun.
- Laporan mutu pelayanan IGD.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah